

Skills abdomen

Table des matières

Général.....	1
1) Anamnèse ciblée.....	1
2) Examen de l'abdomen.....	4
2.1) Marche à suivre.....	5
3) Tableaux cliniques typiques.....	9
3.1) Douleurs oesophagiennes et sous-diaphragmatiques.....	15
3.2) Douleurs abdominales non-digestives.....	16
3.3) Douleurs par localisation.....	17
4) Théorie.....	18

Général

Dans cet examen, il est particulièrement important de mettre le patient le plus à l'aise possible, autrement il contractera sa musculature, sursautera, etc. et on ne sentira rien ! Du coup, ça vaut la peine de lui demander s'il n'aurait pas besoin d'aller aux toilettes pour uriner, de lui demander s'il a froid, de réchauffer le stéthoscope avant de toucher le patient avec, de réchauffer ses mains avant de toucher le patient, etc.

1) Anamnèse ciblée

0) Entrée :

- Se désinfecter les mains
- Saluer le patient et se présenter
- Demander au patient la confirmation de son identité
- Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient
- Demander au patient d'enlever son T-Shirt et de s'allonger en décubitus dorsal, les bras le long du corps, tout en étant totalement détendu (= position de base pour effectuer tout status), même s'il a mal et veut se recroqueviller ! Typiquement, à l'ECOS, le patient ne prendra pas cette position !
Les femmes n'ont pas besoin d'enlever leur soutien-gorge pour cet examen.
Pour bien observer la région inguinale, il faut demander au patient de déboutonner le premier bouton de son pantalon et d'ouvrir sa ceinture
- Se positionner face au patient, ni trop loin, ni trop près, et poser sa bouteille d'eau quelque part

1) Anamnèse actuelle

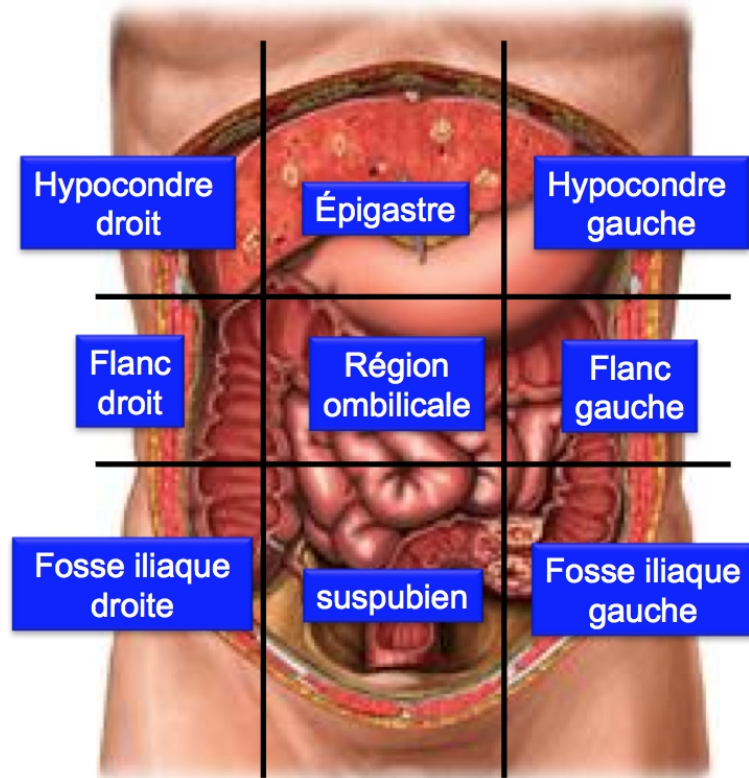
- « Dites-moi ce qui vous amène ? »

2) Caractérisation de la douleur

- 1) Localisation et irradiation
 - Typiquement, les douleurs abdominales sont très vagues, mais elles peuvent parfois se préciser avec le temps ; c'est le cas de l'appendicite : au début, la

douleur est souvent péri-ombilicale (= inflammation du péritoine viscéral, qui n'offre qu'une douleur référée), puis, avec le temps, elle va gentiment migrer en fosse iliaque droite (= l'inflammation se transmet au péritoine pariétal et à la paroi, qui eux ont une innervation somatique précise)

	Douleur viscérale	Douleur somatique
Neurologie	sympathique + parasympathique	nerfs spinaux
Origine	infiltration, étirement, spasme, ischémie	paroi abdominale (péritoine pariétal incl.)
Caractère	mate, profonde, térébrante, colique	aigue, brûlante
Localisation	difficile	précise
Symptômes végétatifs associés	fréquent	rare



- 2) Qualité (serrement, colique, brûlure, décharge électrique, piquûre, coup de poignard, déchirement, etc.) et caractère (douleur ondulante, persistante, etc.)
 - Typiquement, une perforation (vésicule biliaire, appendicite, estomac, etc.) se comportera avec une douleur intense augmentant rapidement (= perforation et dommages à la paroi de l'organe), qui va ensuite graduellement augmenter plus lentement avec le temps (= douleur inflammatoire qui reprend) ; des coliques (biliaires, néphrétiques, iléus, etc.) vont elles typiquement se manifester en ondulante, alternant des phases sans douleur avec des phases très douloureuses ; finalement, une inflammation (appendicite, cholécystite, pancréatite, etc.) va elle être persistante (légèrement ondulante) et devenir de plus en plus forte
- 3) Intensité (échelle de 0 à 10) et évolution
 - Exemplifier l'échelle ou au moins dire « 0 étant une absence de douleur et 10 une douleur insoutenable/la pire douleur qui soit ». Il est aussi important de se renseigner si la douleur évolue avec le temps, par exemple si elle augmente avec le temps (= va en crescendo) ou si elle reste identique, se calme avec le temps, etc.
La douleur est aussi un point important où demander comment le patient se sent vis-à-vis d'elle et comment il vit cette douleur !
- 4) Condition de survenue
 - Qu'est-ce qui a déclenché ce problème ? Depuis quand est-il apparu, pourquoi et

a-t-il évolué depuis ? Faire des liens !

- 5) Chronologie (début, fin, durée, fréquence)
 - Essayer d'approfondir les conditions de survenue, pour savoir si la douleur apparaît avec un effort (si oui quel genre), si elle apparaît au repos, dans une certaine position, avec le froid, quand on avale, avec certains mouvements, après manger, etc. Demander si la douleur apparaît aussi lorsqu'on presse sur le point douloureux ou non, pendant la respiration, etc.
- 6) Facteurs le modifiant (aggravant ou soulageant)
- **7) Manifestations associées** = autres douleurs/éléments liés au problème
 - 7.1) Fatigue
 - 7.2) Vertiges, nausée
 - 7.3) **Fièvre**, frissons
 - 7.4) Modifications de l'appétit, **perte de poids**
 - 7.5) Odyno-dysphagies (= douleurs et/ou peine à avaler) et pyrosis¹ (= renvois acides)
 - 7.6) Fonction intestinale (allé à selles ? Gaz ?)
 - 7.7) Ictère
- Bonus :
 - 1) Comment le patient vit-il la douleur ?
 - 2) Est-ce que c'est la **première fois** que ces douleurs apparaissent ? Si oui, creuser vers les hospitalisations, opérations, etc.
 - 3) Est-ce que la situation a évolué entre avant et maintenant ?
 - 4) Un membre de la famille aurait-il déjà été touché par cette maladie ?
 - 5) Avez-vous déjà pris des médicaments depuis ? Si oui, ont-ils eu un effet sur cette douleur ?
 - 6) Est-ce qu'il y aurait eu un événement précédent cette douleur/quelque chose de particulier qui se serait passé dans les derniers mois/semaines/jours ?

3) Input – output

- 1) Dernier repas
 - 1.1) Mangé (les personnes avec mal de ventre ne mangent souvent pas ou très peu !)
 - 1.2) Bu
 - 1.3) Date
 - 1.4) Type
- 2) Brûlures, nausées, **vomissements**
 - 2.1) Début (+ avant ou après avoir mangé ? Après signerait plutôt un problème

¹ Caractérisation décrite en 1.1

gastrique !)

- 2.2) Description du contenu et de l'aspect (hématémèse ? Bile ? Contenu du repas ?)
- 3) Troubles du transit et gaz (fréquence normale 10 à 12 par jour ; derniers gaz ?)
- 4) Selles
 - 4.1) Changement par rapport à avant
 - 4.2) Fréquence et régularité (normal : entre 3 par jour et une fois tous les 3 jours)
 - 4.3) Consistance (saucisson, bloc de marbre, pétoles, etc.) (selon score de Bristol)
 - 4.4) Couleur (hématochésie (= sang frais dans les selles), méléna (selles noires à cause d'une hémorragie du tractus digestif supérieur ou d'un excès de fer (≠ méléna))
 - 4.5) Odeur (ex. : pancréatite qui provoque une stéatorrhée qui rend les selles très odorantes)
 - 4.6) Sang (dans la cuvette ? Sur le papier ? Mêlé aux selles ?)
 - 4.7) Date des dernières selles
- 5) Plaintes urinaires
 - 5.1) Fréquence
 - 5.2) Douleur
 - 5.3) Odeur
- 6) Éléments féminins
 - 6.1) Pertes vaginales
 - 6.2) Dernières règles/test de grossesse

4) Antécédents personnels

- 1) Maladies, traitements et médicaments
- 2) Les accidents et les blessures
- 3) Les opérations
- 4) Les hospitalisations
- 5) La dernière fois que la personne est allée chez le médecin, quand et pourquoi
- 6) Allergies

2) Examen de l'abdomen

Il faut faire attention au fait que l'ordre des examens est ici différent de l'ordre retrouvé dans les skills pulmonaire, cardiaque et des vaisseaux !

Comme dans tous les examens de l'ECOS de cette année, il est capital de toujours prévenir le patient de ce qu'on va faire (près de la moitié des points passent dans la communication !), d'expliquer à haute voix ce qu'on recherche et ce qu'on voit. Il faut aussi donner l'impression au patient qu'on est

là que pour lui et qu'on ne s'occupe que de lui pour le bref instant pendant lequel on est avec lui.

Pour toutes les différentes parties de l'examen, on commencera toujours du côté opposé à l'endroit où le patient décrit une douleur. Pour la description du lieu de la douleur, ne pas hésiter à demander au patient de pointer du doigt l'endroit en question ou en tout cas de le délimiter avec son doigt si la douleur est diffuse, car on va essayer d'éviter de lui appuyer directement là où il a mal !

Il faut aussi bien tenir ses mains quand on ne fait rien avec.

On parle au patient et pas au ventre !

2.1) Marche à suivre

Dans un status ciblé, il ne sert à rien d'effectuer des tests inutiles comme la palpation de la rate en cas de douleur claire en FID ! De plus, Hahnloser dirait que faire le signe de Murphy serait aussi inutile en cas de suspicion d'appendicite

1) Inspection :

- **Demander au patient s'il a mal quelque part, que ce soit à l'abdomen ou aux reins**
- Visage
 - Signes de douleur
 - Signes de malaise
 - Respiration difficile
- Peau
 - Cicatrices ; on dit ce qu'on fait, on dit qu'on voit/ne voit rien et on demande la confirmation, car les cicatrices d'appendicites sont par exemple très discrètes !
 - Vergetures
 - Veines dilatées (caput medusae)
 - Lésions cutanées
 - Ictère
- Omphalique
 - Localisation
 - Aspect
 - Couleur
 - Hernie visible/voussure
- Allure de l'abdomen
 - Plat, bombé
 - Protubérant
 - Symétrique
- Mouvements
 - Respiratoires ; normal en étant couché = par le ventre. Une respiration 'par les poumons' est typiquement une respiration de quelqu'un qui a mal

- Péristaltiques
- Pulsatiles

2) Auscultation ; redemander où le patient a mal et commencer par l'autre côté.

On indiquera les bruits qu'on perçoit suivant leur qualité (= tonalité) et quantité (= fréquence) (ex. : pour un iléus, on aura soit un 'Ping ping' très métallique arrivant avec une fréquence élevée (= lutte contre un obstacle), soit aucun bruit), en les qualifiant de normo-fréquents et normo-intenses.

Énoncer le fait que 'Je n'ai pas entendu de bruit suspect, donc tout à l'air normal'.

Il est pertinent de demander au patient s'il a mangé ou non avant le test, pour savoir si les bruits qu'on entend sont cohérents ou non avec la situation du patient :

- Écouter successivement les 4 quadrants abdominaux
 - On commence à l'opposé de l'endroit qui fait mal. Il faut bien appuyer le diaphragme du stéthoscope contre la peau pour entendre les bruits, qui devraient être normalement des cliquetis et gargouillis, entre 5 et 34 fois par minute. On doit entendre un bruit dans chaque quadrant, et en l'absence de tout bruit, on peut gentiment pistonner l'endroit pour stimuler le péristaltisme
- Écouter le foyer aortique
 - On écoute le foyer aortique au milieu de l'abdomen (meilleur : péri-ombilical gauche), avec la cloche, à la recherche d'un quelconque souffle

3) Percussion (on ne percute pas ni la rate, ni les reins) :

- Percuter les 4 quadrants
 - On percute successivement les 4 quadrants à la recherche d'air (normal) dans le ventre (l'endroit douloureux étant toujours testé en dernier), indiqué par un tympanisme. En cas d'ascite, on demandera au patient de se mettre sur la gauche, puis la droite et de le percuter à chaque fois ; en effet, l'eau se déplacera avec la gravité, changeant les sons de la percussion !
- Rechercher le foie
 - On commence par percuter sous le mamelon, au niveau des poumons, puis on descend lentement. On devrait passer d'une sonorité à une matité, puis de la matité à un tympanisme. La percussion se fait le long de la ligne médio-claviculaire.
On peut aussi localiser le foie par la méthode du grattage, c'est-à-dire en mettant son stéthoscope au niveau épigastrique, puis en grattant gentiment l'abdomen gauche de haut en bas, avec un doigt. Là où le foie est présent, on entend du bruit, et autre part non

4) Palpation ; on va ici rechercher des éventuelles résistances, signes par exemple de tumeur, ou alors naturellement de la présence du foie, des reins, de la vessie, de ganglions inguinaux, de selles dures, du côlon sigmoïde, de la vessie, etc.

Pendant la palpation, on va également rechercher les signes d'un péritonisme (= irritation péritonéale), en le localisant avec la palpation superficielle, puis en le confirmant par une douleur lors de la décompression brusque/détente :

- Palper superficiellement les 4 quadrants en regardant l'expression du patient
 - **Se fait à une main**, le quadrant douloureux en dernier. Elle sert à lever la résistance musculaire, identifier les structures superficielles et les masses et à

localiser la douleur.

Pour la technique, il suffit de mettre 3 ou 4 doigts de sa main sur le ventre et de gentiment masser

- Palper profondément les 4 quadrants en regardant l'expression du patient
 - **Se fait à deux mains**, le quadrant douloureux en dernier. Pour toute masse qui serait repérée, il faut en préciser la localisation, la forme, la taille (faire des analogies ; ex. : comme une pièce de 1fr, etc.), la surface, les contours (diffus ou précis), la consistance, la sensibilité (= douleur ou pas douleur), la mobilité et la pulsation.
Pour la technique, on met les mains les unes sur les autres, une explorant et l'autre poussant et on explore avec les doigts. On masse comme pour le superficiel et on descend gentiment de superficiel à profond
- Défense/détente dans les 4 quadrants
 - On enfonce lentement et assez profondément une de ses mains dans un des quadrants et on demande si le patient à mal. On va tenir sa main enfoncée dans le ventre pendant quelques secondes, puis on va ensuite retirer rapidement sa main et redemande si le patient à mal.
La **défense**² est le mécanisme de défense du corps qui empêche la palpation profonde et est surtout un signe d'atteinte du péritoine pariétal. On retrouve une contraction involontaire des muscles qui protègent l'endroit inflammé, mais cette contraction involontaire peut aussi se retrouver si le patient est stressé, auquel cas la palpation superficielle permettra d'abord de détendre la musculature ; de même, elle peut être provoquée par une palpation trop brusque !
La **détente** vient des feuillets de péritoine qui se frottent ensemble et produisent une vive douleur lors de la décompression et est surtout un signe d'atteinte du péritoine viscéral. Elle peut apparaître même assez loin de la zone inflammée. On pourrait retrouver une « hyperesthésie cutanée »
- Recherche d'une appendicite
 - Signe de McBurney : on localise l'appendicite antérieure en pointant le tiers inférieur d'une ligne imaginaire tracée entre l'ombilic et l'épine iliaque antéro-supérieure
 - Signe du psoas : on localise l'appendicite postérieure en demandant au patient allongé d'essayer d'élever sa cuisse (tendue et complètement droite) contre résistance (douleur lancante dans le bas du dos)

5) Examen spécifique du foie, de la rate, des reins et de l'aorte

- Foie
 - Estimer sa taille, sa forme, sa sensibilité et sa consistance.
On le palpe avec la main droite (en dehors du m. grand droit), la gauche étant derrière les 11 à 12ème côtes pour soulever le foie.
On peut également palper le foie à deux mains, en formant un 'front' avec les deux mains, puis en allant explorer la zone sous le rebord costal.
Comme on ne sait pas si le patient a une hépatomégalie, dans les deux types de palpation, on commence depuis ~ l'ombilic, puis on remonte. Si on a de la peine à sentir le foie (et surtout pour les patients obèses), on peut demander au patient

2 Autre moyen de la tester : prendre l'abdomen à deux mains et gentiment secouer le ventre

d'inspirer profondément (= le diaphragme pousse le foie) ou utiliser la 'technique du crochet' (= se mettre vers la tête du patient et lui attraper les côtes)

- Signe de Murphy : dans le but de détecter une affection de la vésicule biliaire (majoritairement des cholécystites), on demande au patient d'inspirer, on positionne ses deux mains sous le rebord costal, puis on demande au patient d'expirer pour nous permettre d'enfoncer les mains, et finalement on lui demande de réinspirer, ce qui devrait faire très mal, car l'inspiration pousse le foie (et la vésicule biliaire !) sur nos doigts.
Un signe de Murphy est considéré positif lorsque la manoeuvre provoque une douleur et un blocage de l'inspiration
- Rate (on ne la percute pas)
 - On positionne sa main gauche derrière les côtes du patient pour pousser la rate vers le haut et on essaie de la palper avec la main droite, sous le rebord costal ; on demande finalement au patient d'inspirer profondément. Normalement, on ne devrait rien sentir, sauf chez les patients très maigres ou avec une splénomégalie, qui fait descendre la rate vers le bas à droite
- Reins
 - On essaie de les palper juste après la rate, en utilisant la même technique toujours avec la main gauche qui surélève les côtes et la main droite qui palpe. On ne devrait pouvoir les palper que si leur taille est augmentée
 - On demande au patient de s'asseoir, puis on se positionne derrière lui. On peut lui redemander s'il aurait une douleur dans le dos, vers le bas des côtes, puis on lui annonce qu'on va percuter. Pour ce faire, on positionne sa main gauche (~ niveau de la 12ème côte) comme enclume (en soulevant légèrement les côtes) sur un des reins du patient et on tape modérément comme pour casser des noix. La moindre vibration devrait le faire sauter au plafond s'il a une pyélonéphrite
- Aorte
 - Appuyer fermement sur la partie supérieure de l'abdomen, légèrement à gauche (peut se faire à une ou deux mains, mais à deux mains c'est plus facile). On devrait sentir une petite pulsation ou rien du tout (chez les gens maigres on sent cette pulsation assez fort)

6) Orifices herniaires :

- Observer les régions abdominale et crurale à la recherche de voussures
 - On a 5 orifices herniaires possibles : épigastrique (fréquent), ombilical (très fréquent), inguinal, fémoral et cicatriciel.
On essaie premièrement de trouver la présence de hernies à l'oeil nu, les 5 hernies possibles pouvant être facilement visibles.
Pour détecter la hernie ombilicale, on met un doigt dans le nombril du patient, puis on lui demande de relever la tête. Si quelque chose essaie de sortir, c'est un alien.
Pour la hernie inguinale, on demande simplement au patient de relever la tête et on observe la région inguinale. On peut aussi suivre le cordon spermatique avec son doigt et demander au patient de tousser
- Si on voit une hernie, peu importe laquelle, on va toujours se poser ces 3 questions :

- 1) Symptomatique ou non (= fait mal ou non ; gêne ou non)
- 2) Réponible (= pas incarcerated) ou non (= incarcerated)
- 3) Si la hernie est incarcerated : strangulée ou non

7) Toucher rectal : on finit avec 'J'ai terminé l'examen de l'abdomen et je transmettrai toutes les informations au Dr. X. Je vais maintenant me référer à mon chef, mais je pense qu'un toucher rectal serait pertinent'

3) Tableaux cliniques typiques

Remarque : si ni l'anamnèse, ni l'examen clinique ne nous permettent de classer les patients en SAA (Surgical Acute Abdomen) ou en NSAA (Non-SAA), avant de faire des investigations supplémentaires, on va calmer la douleur du patient !

Remarque 2 : en général, on demandera un labo pour tous les patients venant avec un abdomen aigu, et on demandera le plus souvent :

- Recherche d'inflammation : FSS + CRP
- Recherche d'anomalies rénales : K⁺ + Na⁺ + urée + créatinine
- Recherche de problèmes hépatiques ou de cholestase : bilirubine + γ -GT + PA (= Phosphatase Alcaline) + ASAT + ALAT
- Recherche de problèmes de coagulation : crase

Tableaux cliniques :

- Coprostase/FOSS (= Full Of Shit Syndrome) :
 - Anamnèse : douleurs abdominales crampiformes, pas de fièvre, pas de CRP ou de leucocytose, ballonnée, peut avoir des selles (= même si on est constipé, on peut continuer à avoir des selles, mais beaucoup moins que d'habitude !)
 - Clinique : douleurs très diffuses, abdomen souple, sans défense ni détente
- Toutes les douleurs gynécologiques, notamment la grossesse et la torsion ovarienne !
- Appendicite :
 - Anamnèse : douleur continue tout d'abord vague et périombilicale, se localisant en FID avec le temps, accompagnée de vomissements, nausée, un arrêt du transit (pas nécessairement), une fièvre et une tachycardie. Touche le plus souvent les sujets jeunes et masculins
 - Clinique : signe de défense et de détente en FID. D'après papa, la détente controlatérale est le signe qui tue pour détecter les appendicites !
 - Examens complémentaires : si gros doute, demander des US en complément (recherche du 'signe du cocarde'), et si les US ne sont pas clairs ou ne donnent rien, passer au CT
 - Remarque : si l'appendicite est localisée et n'a pas encore perforé, la douleur (ainsi que défense et détente) se concentreront le plus souvent en FID. Si l'appendicite se complique et perfore, tout le ventre sera douloureux

- Perforation (le plus souvent gastrique) :
 - Anamnèse : douleur subite, rapidement croissante, localisée de manière épigastrique, sans vomissements, avec nausées, une fièvre et une tachycardie. On peut retrouver une prise d'AINS, qui favorisent grandement les risques d'ulcère gastrique/duodéal ! Touche 3 fois plus fréquemment les hommes
 - Clinique : signe de défense et de détente dans l'épigastre et absence de bruits intestinaux
 - Examens complémentaires : il faut systématiquement demander au moins une radio thoracique debout (le mieux, rechercher d'accumulation d'air sous les coupes diaphragmatiques), sur le côté ou couché (recherche du signe de Rigler/de la double paroi abdominale) (et pas un ASP) pour repérer le pneumopéritoine ; autrement, si on ne sait toujours pas quoi faire, demander un CT
- Diverticulite (le plus souvent sigmoïde)³ :
 - Anamnèse : douleur constante durant plusieurs jours, augmentant soudainement en intensité, souvent en FIG, sans vomissements, sans problèmes de selles, avec fièvre. En cas de fistule avec la vessie, on peut retrouver une pneumaturie. La diverticulite touche plus souvent les personnes plus âgées avec régime pauvre en fibres
 - Clinique : signe de défense et de détente en FIG
 - Examens complémentaires : CT avec produit de contraste dans l'anus à la recherche de diverticules (paroi très fine, souvent avec un peu d'air dedans), abcès, oedèmes ou épaississement (presque à chaque fois) de la paroi du sigmoïde (le plus souvent). Le traitement est principalement conservateur, sauf en cas de complication (abcès > 4cm, fistule, sténose et) ou si récidivant (> 4 poussées) ou si la personne est jeune (< 50 ans)
 - Remarque : triade typique : fièvre + douleurs en FIG + arrêt du transit
- Iléus :
 - Anamnèse : douleurs crampiformes depuis plusieurs jours (mais peuvent aussi être aiguës !), en augmentation (pas toujours), péri-ombilicales, sans irradiation, qui diminuent une fois que le patient est couché, sans fièvre (mais parfois leucocytose), mais souvent avec un arrêt du transit (touche parfois gaz, surtout selles) qui est arrivé avant ou en même temps que les douleurs, parfois hernies. Dans 75% des cas, les patients ont déjà eu une opération abdominale auparavant ! Les deux symptômes les plus retrouvés sont la douleur (> 90%) et les vomissements (70%), moins le météorisme (50%) et les arrêts du transit (30%)
 - Clinique : pas de signe de défense et de détente (on peut quand même parfois les retrouver, surtout dans les iléus de strangulation !), douleur diffuse dans l'abdomen et météorisme (= bruit entendu à la percussion avec une grande quantité d'air présente dans les intestins), « ting-ting » très métallique si iléus obstructif, sinon moins/aucun bruit si iléus paralytique
 - Examens complémentaires : si tous les autres signes restent peu clairs, demander un CT
- Ischémie mésentérique aiguë :

3 Diagnostic posé uniquement avec l'anamnèse !

- Anamnèse : douleurs atroces, ne diminuant pas avec les antalgiques puissants comme la morphine, sans localisation précise. Toujours rechercher si ces patients ont une ischémie mésentérique chronique (50% !), des signes de thrombose artérielle (déjà eu une thrombose artérielle ou ischémie mésentérique chronique), embolie artérielle (patients âgées, FA, infarctus, AVC, embolie concomitante, déjà eu une embolie, etc.) et de thrombose veineuse (femme, enceinte, contraceptifs, trauma, inflammations, post-opératoire, etc.). Ce sont surtout les femmes âgées qui sont touchées. Souvent présence d'une forte leucocytose
- Clinique : pas de péritonisme et ventre très souple
- Examens complémentaires : angio-CT (ou très rarement angio-IRM) pour repérer des calcifications, caillots, embols, etc.
- Remarques : les signes cardinaux d'une ischémie mésentérique sont une discrépendance entre les symptômes cliniques (= ventre souple, pas de péritonite) et l'état général (douleur atroce), une douleur atroce et une forte leucocytose.
Dans les ischémies mésentériques chroniques, on retrouve une « fear for food » à cause d'un angor intestinal/claudeication post-prandiale apparaissant après que les patients aient mangé
- Abcès post-opératoire :
 - Peut faire une douleur diffuse, avec ou sans signe de défense et/ou de détente
- Choliques hépatiques :
 - Anamnèse : douleurs à 10/10 (comme pour les coliques néphrétiques), d'apparition subite, rapidement insoutenables, dans l'hypochondre droit ou dans l'épigastre, pouvant irradier vers l'omoplate. On peut retrouver une inhibition respiratoire (= signe de Murphy) et des nausées/vomissements. Absence de fièvre ou d'ictère et spontanément régressives après quelques heures. Peut être déclenché par un repas copieux (typiquement la chasse à cause de sa sauce ou la fondue chinoise à cause de ses sauces) ou de l'alcool
 - Clinique : le signe de Murphy peut être positif, pas de défense, pas de détente
 - Examens complémentaires : demander des US de l'abdomen
- Cholécytite :
 - Anamnèse : douleurs intenses (à 10/10 si choliques hépatiques concomitantes), très souvent post-choliques hépatiques ou lithiases vésiculaires. On retrouve de la fièvre, une CRP et des leucocytes élevés
 - Clinique : signe de Murphy souvent positif, parfois défense et/ou détente
 - Examens complémentaires : toujours demander des US d'abord (permet de détecter un calcul pas trop bas et de caractériser un hydrops vésiculaire), puis une cholangio-IRM si on ne trouve rien
 - Facteurs risque : 6 F : Female, Fertile, Forty, Fat, Family et Fair
 - Remarque : comme les cholécystites sont le plus souvent causées par des lithiases vésiculaires se bloquant dans le col vésiculaire ou dans le canal cystique, on retrouve rarement des ictères concomitants. Par contre, dans les cholédocholithiases (typiquement symptomatologie cholécystite (signe de Murphy compris) + ictère ± pancréatite aigüe), on va parfois retrouver une cholécystite, mais beaucoup plus

souvent un ictère, absent dans les cholécystites !

– Cholangite⁴ :

- Anamnèse : ictère (post-hépatique), urines foncées, selles décolorées, inappétence et fièvre. Cette constellation ne peut pointer que vers une cholangite !
- Clinique : signe de Murphy souvent positif, parfois défense et/ou détente
- Examens complémentaires : toujours demander des US d'abord (permet de détecter un calcul pas trop bas et de caractériser un hydrops vésiculaire), puis une cholangio-IRM si on ne trouve rien

– Choliques néphrétiques :

- Anamnèse : douleurs coliques à 10/10, sans position qui améliore, d'apparition subite. Naissent dans le dos, puis peuvent se déplacer en suivant le trajet urétéral. Souvent accompagnées de vomissements
- Clinique : ventre totalement souple, sans défense ni détente ; par contre, on retrouve une **douleur à la percussion des loges rénales**, le/les pyélon/pyélons étant sous pression !
- Remarque : des douleurs coliques sans trouble du transit apparent doivent toujours faire penser à des coliques néphrétiques ! De plus, une douleur chronique, dans le dos, qui répond à la palpation profonde et aux vibrations des reins (cf. C. !) doit faire penser à une lithiase chronique !

– Pyélonéphrite :

- Anamnèse : fièvre (fréquente, alors qu'elle est rare dans les cystites !), douleur dans le flanc, nausée/vomissements et éventuellement cystites pouvant l'accompagner (car contamination de l'urine qui s'infecte). Le patient peut se plaindre de douleurs lombaires à la vibration et/ou aux chocs (ex. : descendre les escaliers)
- Clinique : ventre totalement souple, sans défense ni détente, sauf éventuellement à la palpation bimanuelle des loges rénales. On retrouvera par contre de vives douleurs lorsqu'on soumet le patient à des vibrations (ex. : lorsqu'il est couché, passer une main au niveau du rein et gentiment pousser le rein vers nous ; on peut aussi le faire lorsque le patient est assis et qu'on le secoue/balance un peu) ou à la percussion des loges rénales
- Remarque : si on oublie la palpation ou la percussion des reins, on peut passer à côté d'une pyélonéphrite, car cette douleur peut parfois mimer celle d'une appendicite ! De plus, une pyélonéphrite obstructive (= pyélonéphrite sur obstruction par un calcul rénal) = douleur dans les loges rénales + fièvre) est une urgence médicale, à traiter le plus rapidement possible par néphrostomie, au risque de perdre le patient en quelques heures !

– Globe vésical :

- Anamnèse : douleur sus-pubienne avec besoin horrible d'aller uriner. Chez une personne âgée, peut ne se manifester que par un état confusionnel
- Clinique : douleur à la palpation, matité à la percussion, masse sus-pubienne
- Remarque : dans les causes les plus fréquentes, on retrouve les obstructions (HBP,

4 Diagnostic posé uniquement avec l'anamnèse !

cancer de la prostate, etc.), les vessies neurogènes (spina bifida, sclérose en plaques, trauma médullaire, syndrome de la queue de cheval, chirurgie abdominale, etc.) et médicamenteuses (neuroleptiques anticholinergiques)

- Saignement anal (= sang dans les selles) :
 - Anamnèse : demander :
 - Combien
 - Fréquence (tout le temps ? Seulement en allant à selles ?)
 - Associé à... (ex. : douleurs)
 - Anamnèse familiale
 - Antécédents personnels (poussée de RCUH ?)
 - Médicaments
 - On regarde d'abord si le saignement est anal (ordre décroissant de fréquence : hémorroïdes > fissure > fistule > proctite). Si ce n'est pas le cas, le saignement est soit digestif haut (dans 90% des cas), soit digestif bas.
Dans un saignement digestif haut, on retrouve : ulcères > érosions (= gastrites ou duodénites) > varices > Mallory-Weiss > oesophagites. Dans un saignement digestif bas (touche presque exclusivement les personnes âgées), on retrouve : diverticulose > angiodysplasies > néoplasies > colites ischémiques > Crohn + RCUH
 - Regarder si le sang est dans la cuvette (souvent hémorroïdes), avec les selles (souvent atteinte du côlon), sur les selles (souvent atteinte du rectum) ou digéré dans des selles noires (souvent hémorragie digestive haute) permet d'indiquer l'origine du saignement
 - Un patient jeune touché par une hémorragie digestive basse aura plutôt tendance à souffrir d'un Meckel ou d'une IBD
- Dissection aortique :
 - Anamnèse : douleur très violente, médiane, avec irradiation dorsale. Peut aussi être pauci-symptomatique et ne se manifester que par des artériopathies périphériques (= douleurs dans les jambes par embols artériels) et une douleur dans le flanc. Rechercher les principaux FRCV (homme âgé et fumeur)
 - Clinique : palpation et recherche de souffle. De base, toute masse pulsatile avec des douleurs très intenses dans le ventre doit être considérée comme une rupture d'anévrisme de l'aorte !
- Pancréatite aigüe :
 - Anamnèse : localisation épigastrique, avec irradiation dans le dos en forme de ceinture et souvent accompagnée de vomissements. S'installe en quelques heures, voire quelques jours tout au plus
 - Clinique : défense et détente dans toute la partie haute du ventre
- Pancréatite chronique :
 - Anamnèse : douleur varie considérablement, de totalement absente à constante ou en crises successives ; la douleur augmente au fur et à mesure des mois/années. Elle est souvent de localisation épigastrique, avec irradiation dans le dos en forme de

ceinture et est souvent accompagnée de vomissements

- Clinique : défense et détente dans toute la partie haute du ventre, parfois rien du tout
- Ulcère duodénal :
 - Anamnèse : douleur variable, parfois avec hématemèse (plutôt méléna), rarement prise d'AINS. Classiquement, elle est présente à jeun, puis se calme après les repas
 - Clinique : défense épigastrique
 - Examens complémentaires : OGD, IPP et éradication Hp
- Ulcère gastrique :
 - Anamnèse : douleur variable, parfois avec hématemèse (plutôt méléna), avec prise d'AINS dans 25%. Classiquement, elle est présente après les repas et est soulagée par la prise alimentaire ; elle apparaît aussi typiquement pendant la nuit
 - Clinique : défense épigastrique
 - Examens complémentaires : OGD, IPP et éradication Hp
- Ventre ballonné : les 6 G : Graisse, Gaga (= FOSS), Gaz, Grossesse, Grandes eaux (= liquide libre), Grosse tumeur
- Crohn :
 - Anamnèse : douleur abdominale variable, parfois appendicite-like, souvent diarrhées, rarement du sang, parfois des constipations. Symptômes extra-digestifs (articulaires, oculaires, osseux, cutanés, etc.), souvent perte de poids. Crohn péri-anal dans 30% des cas, se déclarant dans 50% du temps avant la maladie !
- RCUH :
 - Anamnèse : douleur abdominale variable, parfois diarrhées, quasi-systématiquement du sang, jamais de constipation (ou méga-côlon !). Symptômes extra-digestifs (articulaires, oculaires, osseux, cutanés, etc.), souvent perte de poids
- Côlon irritable (constipation, diarrhée ou mixte) :
 - Anamnèse : diagnostic purement anamnestique, reposant en partie sur l'exclusion d'autres maladies. Touche plutôt les patients jeunes et, selon les critères de Rome IV : douleurs abdominales au moins une fois par semaine depuis 3 mois, avec (2 ou plus) (1) douleurs en lien avec la défécation (ex. : peuvent être soulagées après défécation), (2) anomalie de la fréquence ou (3) anomalie de la forme/apparence des selles. On a typiquement une absence de symptômes nocturnes, d'amaigrissement, de fièvre, de sang dans les selles, etc. (= de symptômes organiques qui pourraient par exemple évoquer une maladie inflammatoire intestinale). On retrouve typiquement des flatulences, des ballonnements (= météorisme).
Une gastro-entérite bactérienne, une prise récente d'antibiotique et une mauvaise qualité de vie augmentent les risques de survenue !

Différents types de douleurs et leurs DD :

- 1) Agonique (= très rapidement à 10/10 et se maintient) :
 - Rupture d'anévrisme

- Appendicite phlegmoneuse
- Perforation (gastrique)
- Torsion testiculaire ou ovarienne
- 2) Constante et progressive
 - Diverticulite
 - Pyélonéphrite
 - Ischémie mésentérique
 - Cholécystite (≠ coliques biliaires !)
- 3) Variable (= les coliques)
 - Coliques digestives
 - Coliques néphrétiques
 - Coliques biliaires

3.1) Douleurs oesophagiennes et sous-diaphragmatiques

Remarque : une douleur oesophagienne peut mimer une douleur cardiaque, mais on peut les distinguer par :

- Douleurs œsophagiennes plutôt en lien avec les repas vs douleurs cardiaques plutôt en lien avec l'effort
- Douleurs oesophagiennes toujours au milieu du thorax vs douleurs cardiaques qui peuvent aller dans le thorax, les bras, la mâchoire, etc.

On en retrouve principalement 3 grands types de douleurs oesophagiennes :

- 1) Reflux gastro-oesophagien/RGO⁵ : brûlure rétro-sternale (= pyrosis) + régurgitations acides = RGO dans > 95% des cas ! On peut également retrouver des douleurs rétro-sternales, une dysphagie et une hématemèse (rare, le plus souvent en marc de café). Souvent après un repas ou en lien avec, déclenché par les changements de position ou certaines positions (couché ou penché en avant). Il peut ne se manifester que par de la toux et de l'asthme
- 2) Spasme oesophagien ou nutcracker oesophagus : douleur rétro-sternale constrictive, déclenchée par la déglutition. Elle est souvent brève et récidivante. Elle peut être calmée par la trinitrine, qui est un donneur de NO => énorme piège, car cette douleur irradie dans la même zone qu'une douleur coronarienne et peut être calmée par le même médicament !
- 3) Rupture oesophagienne : douleur brutale, intense, de type déchirure, rétrosternale et basi-thoracique gauche, accompagnée de vomissements
- [4) Infections (candidose et herpès surtout, mais généralement rares)]

On retrouve plusieurs lieux d'irradiation des douleurs sous-diaphragmatiques :

⁵ Diagnostic posé uniquement avec l'anamnèse !

- Basi-thoracique : plutôt d'origine digestive
- Épaule droite : souvent d'origine hépatique
- Lombaire haute : souvent d'origine rénale ou biliaire

3.2) Douleurs abdominales non-digestives

Pathologies d'origine sus-diaphragmatique :

- Cardiaque :
 - Infarctus myocardique inférieur : peut donner des douleurs épigastriques avec nausées et vomissements => anamnèse de gastrite, mais l'ECG tranche. De plus, la douleur s'intensifie les jours suivant avec des signes de décompensation cardiaque ou un galop audible
 - ICD : hépatomégalie, splénomégalie et éventuellement ascite => ventre sous tension avec inapétence, pesanteur abdominale, nausée, vomissement, douleurs dans l'hypochondre droit, constipation
 - Péricardite (rarement)
- Pulmonaire :
 - Pneumonies touchant les bases pulmonaires : symptômes respiratoires prédominants avec parfois (~ 25% du temps !) des symptômes digestifs accompagnateurs, comme des douleurs abdominales (même parfois péritonites), des nausées ou des diarrhées. Rarement symptômes purement digestifs
 - Pleurésies (rarement)

Pathologies urinaires :

- Douleur rénale (ex. : pyélonéphrite) : douleur sourde, en arrière ou sous le rebord costal, elle peut irradier en avant vers l'ombilic
- Colique néphrétique : douleur intense, qui naît au niveau de l'articulation costo-vertébrale et suit le trajet urétéral, jusque dans les lèvres/bourses, parfois même jusqu'à la cuisse. On rencontre souvent des vomissements avec ! Peut se déplacer avec le temps jusqu'à atteindre ce tableau
- Globe vésical : douleur sus-pubienne + masse avec matité + besoin horrible d'aller uriner. Chez une personne âgée, peut ne se manifester que par un état confusionnel. Dans les causes les plus fréquentes, on retrouve les obstructions (HBP, cancer de la prostate, etc.), les vessies neurogènes (spina bifida, sclérose en plaques, trauma médullaire, syndrome de la queue de cheval, chirurgie abdominale, etc.) et médicamenteuses (neuroleptiques anticholinergiques)

Pathologies d'origine vasculaire (toutes des urgences (mais seulement dissection aortique et ischémie artérielle sont vitales) !) :

- Dissection aortique : douleur très violente, médiane, avec irradiation dorsale. Peut aussi être pauci-symptomatique et ne se manifester que par des artériopathies périphériques (= douleurs dans les jambes par embols artériels) et une douleur dans le flanc. Rechercher

les principaux FRCV (homme âgé et fumeur). Toujours faire anamnèse + palpation + auscultation (recherche de souffle)

- Ischémie artérielle : douleurs abdominales atroces, sans aucune défense ni détente. Si problème chronique, alors claudication post-prandiale. Rechercher les FRCV
- Thrombose veineuse : rarement aiguës, elles sont plutôt chroniques et chez les personnes avec antécédents thrombo-emboliques, avec cancer ou sous contraception. Les douleurs sont semblables à celles d'ischémie artérielle mésentérique chronique, mais en encore plus vague. Les deux populations les plus touchées sont les jeunes femmes avec contraception nouvelle et les vieilles femmes sous traitement hormonal nouveau
- Vasculites : tableau large touchant beaucoup d'autres organes (peau, reins, poumons, etc.) et secondairement les intestins
- Hématome pariétal : difficiles à repérer à la palpation (très traîtres, car se situent souvent dans les fesses, cuisses et dans le ventre), bien visibles au CT. Typiquement accompagnés de baisse de TA, syncope et accélération du pouls, secondairement de douleurs abdominales. Touchent surtout les patients anti-coagulés ou ayant subi un traumatisme. Hypotension nouvelle + douleurs abdominales doivent faire suspecter un hématome abdominal !
- Splénomégalie et rupture de rate : sous forme aiguë, on retrouve surtout les traumatismes (avec le signe de Kehr = douleur dans l'épaule gauche) et les infections virales (CMV et EBV = la mononucléose !); sous forme chronique, on retrouve plutôt les causes infectieuses, la cirrhose et l'hémopathie maligne (ex. : leucémie myéloïde chronique). On peut palper la rate (si on la sent => pathologique !), la percuter et faire le scratch test (= déterminer sa taille avec le stéthoscope)

Toutes les masses abdominales :

- Masse surrénalienne (ex. : tumeurs => recherche d'hyper-sécrétion hormonale)
- Lymphome
- Tumeurs solides

Pathologies endocriniennes et métaboliques :

- Insuffisance surrénalienne aiguë : douleurs abdominales au second plan, avec une fatigue extrême et hypotension
- Thyrotoxicose : énorme appétit, tachycardie, tremblements, diarrhées, perte pondérale
- Hypercalcémie : asthénie, anorexie, polyurie, constipation

Tous les problèmes gynécologiques, notamment la grossesse (surtout chez les femmes jeunes) et les torsions ovariennes

Atteintes autres : fractures vertébrales, déformations de la cage thoracique, zona, etc. On retrouve également toutes les douleurs d'origine psychogène !

3.3) Douleurs par localisation

- Épaules : épaule droite plutôt foie ou vésicule biliaire, épaule gauche plutôt rate
- Thoracique : oesophagienne, pulmonaire ou cardiaque
- Épigastrique : dyspepsie⁶, RGO, ulcères, tumeurs/lymphomes, pancréas
- Hypochondre droit : hépatites, cholécystites, cholangites, calculs biliaires => toujours demander des US, puis une ERCP, rarement une IRM ou un CT
- FID : appendicite, Crohn, côlon irritable => colonoscopie bonne idée
- FIG : diverticulite, Crohn, RCUH, colite (ischémique ou infectieuse), côlon irritable, tumeur
- Tout le cadre colique : tumeur (plutôt personnes âgées), côlon irritable (plutôt personnes jeunes), polypes, Crohn, FOSS
- Dos : pancréatites aiguë et chronique, dissection d'anévrisme de l'aorte
- Hanche : douleur dans le rétropéritoire en FIG ou FID

4) Théorie

On recherche avant tout des signes de péritonite primaire (sans infection, pouvant être due à une cirrhose hépatique, un lupus érythémateux, une carcinomatose péritonéale, etc.) ou secondaire (inflammation/infection du péritoine à cause de bactéries (95%), chimique/toxique (urine, bile, produit de contraste, etc.), post-radique, etc.). Elle peut être **localisée** ou **généralisée** (ventre de bois) et peut être représentée par une détente ou défense seule ou une combinaison des deux.

Pour l'examen, on divise l'abdomen en 4 quadrants, mais une localisation précise pour une douleur devra utiliser le découpage en 9 cadrans (hypochondres (droit et gauche), épigastre, flancs (droit et gauche), région ombilicale, fosses iliaques (droite et gauche) et sus-pubienne/hypogastre), plus précis.

Conditions générales : il faut un bon éclairage, le patient doit être détendu, l'abdomen est complètement mis à nu (et on dégage les régions inguinales en faisant ouvrir la ceinture et en ouvrant un bouton) et la vessie du patient doit être vide (on pousse fort sur l'abdomen). Les mains de l'examineur doivent être chaudes, ses ongles courts.

Le patient doit être couché confortablement sur le dos, avec un coussin sous la tête et les bras le long du corps. Il est important d'expliquer et de prévenir le patient de toutes les manipulations !

Palpation :

- Le foie est difficile à palper, situé à l'arrière des côtes et faisant entre 6cm et 12cm de haut
- La **rate et les reins** (se trouvent entre les côtes 11 et 12) ne sont **normalement pas palpable du tout**, mais on les palpe pour rechercher une anomalie éventuelle
- On fait passer la palpation en dernier, car si on commence directement par la palpation, on risque d'activer le transit et de biaiser l'auscultation et les bruits entendus
- Si le patient est tendu, on peut lui demander d'expirer pendant qu'on palpe ou encore lui demander de respirer par la bouche, avec la mâchoire tombante

6 Cf. 4) Théorie

Pour ne plus se tromper :

- Dyspepsie : peut être des symptômes ou un diagnostic. Les critères de Rome III définissent les symptômes dyspeptiques comme (1) un inconfort abdominal post-prandial, (2) une satiété précoce ou (3) des douleurs ou brûlures épigastriques ; ces symptômes comprennent donc (point (3)) les RGO et ulcères ! On ne parlera de diagnostic que lorsque toutes les causes possibles de ces symptômes dyspeptiques ont été éliminées. Il peut parfois être utile de traiter Hp dans les dyspepsies.
Normalement, avant 50 ans, on traite toute les dyspepsies, alors qu'après 50 ans, on va plutôt faire un bilan, car on retrouve plus souvent des causes organiques et dangereuses !
- RGO : reflux acide de l'estomac. Il n'a pas encore été démontré que le traitement d'Hp avait une quelconque influence sur eux !
- Ulcères : gastrique ou duodénal, ils sont presque systématiquement dus à Hp => le traiter est donc une priorité !